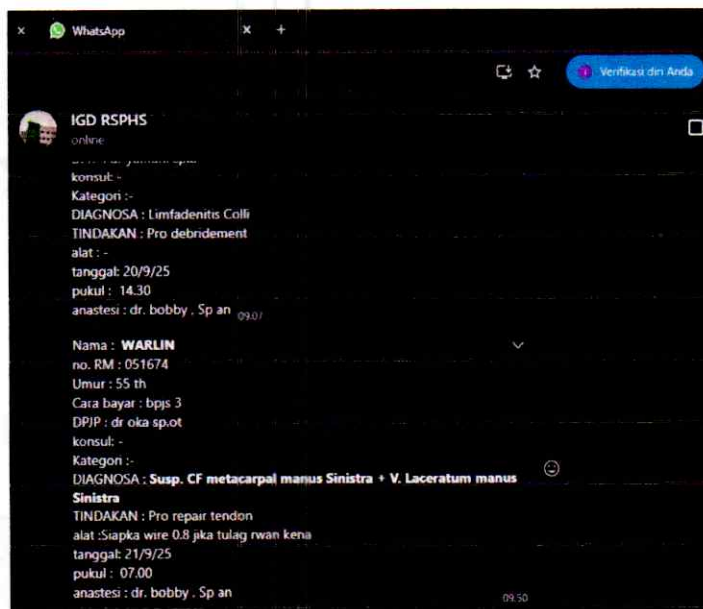


I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Agung Pratama, Amd. Kep
2	Kejadian	Operasi
3	Unit Kerja yang terlibat	IKO
4	Tanggal Kejadian	21 September 2025

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
20/09/2025	09.45	Pada hari Sabtu, 20/09/2025 IKO mendapat laporan operasi dari IGD Pasien atas nama Tn. Warlin (051674) dengan diagnose Rupture Extension Tendon yang akan dilakukan tindakan Repair Tendon pada hari Minggu, 21-09-2025 pukul 07.00. (sudah ACC dr. Bobi Sp. An). Tim IKO mengkondisikan laporan ke dr. Oka Sp. OT dan dr. Bobi Sp. An.	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	06.30	Pasien dari ruang 2B turun ke Pre op. perawat Danang melakukan Handover dengan perawat Asma dengan anamnesa pasien mengatakan nyeri pada luka tangan kiri terkena sabit saat memberi makan sapi, TD: 120/80 mmHg, N: 80x/menit, S: 36 C, RR: 20x/menit.	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	07.00	dr. Oka Sp. OT datang dan memberi edukasi mengenai Tindakan yang akan diberikan diruang Pre Operasi yang di damping perawat Danang. Kemudian memberi advice Bius. Tetapi dr. Bobi Sp. An tidak datang dan beliau menghubungi perawat Agung dalam melakukan pendelegasian tugas.	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	07.20	Perawat Agung melakukan pembiusan dengan General Anestesi sesuai Advice dari dr. Bobi Sp. An yang di awasi dr. Oka Sp. OT. Sambil menunggu tim Cuci tangan. Setelah pasien di bius, perawat Wafi dan Kikis melakukan drapping. Dan dr. Oka Sp. OT melakukan Cuci Tangan.	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	07.30	Kemudian Sirkuler (Danang) melakukan Time out dengan menyebutkan identitas pasien, diagnosis, rencana yang akan dilakukan dan menyebutkan jumlah kassa dan nama tim antara lain : Operator : dr. Oka Sp. OT Asisten : Wafi dr. Anestesi : dr. Bobi Sp. An Asisten : Agung Instrumen : Kikis Onloop : Danang profilaksis dan premedikasi sudah dimasukkan sesuai advice. Instrumen menyebutkan jumlah kasa 10, mess 1, alat 16 dan jarum 1. kemudian perawat Danang meminta tolong kepada dr Oka Sp. OT untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum tindakan operasi dimulai. Operasi dimulai sesuai SOP.	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	07.33	Pasien awal dilakukan irigasi dan debridement, kemudian didapatkan rupture extensor tendon dan dilakukan repair tendon dan dijahit menggunakan benang T-Lene 4.0	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	08.00	Onloop melakukan sign out dengan mengkonfirmasi operator tindakan debridemen dan instrumen menyebutkan jumlah kasa, deppers, mess dan alat sesuai dengan jumlah saat time out.	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	08.05	Setelah operasi selesai, pasien di bersihkan dan luka ditutup menggunakan cuticle dan kasa lalu di balut elastomull. Setelah itu pasien dipindahkan ke ruang post operasi untuk di observasi.	Agung, Wafi, Kikis, Danang
21/09/2025	08.10	Px dipindahkan ke RR dengan kondisi TD =110/82 mmHg, N =84x/menit, Spo2 =99%.	Agung, Wafi, Kikis, Danang





21/09/2025	09.00	Px akan pindah ke ruang rawat inap 2B, perawat Danang mengoperkan kondisi pasien sebelum pindah ruangan dengan Perawat Elly, perawat Danang mengoperkan pasien dengan diagnosa Post Operasi Repair Tendon, GCS 4/5, TD 110/80 mmHg N 82x/mnt S 36 °C RR 20 x/mnt SpO2 99%, pasien mendapatkan advice dari dr Oka Sp. OT : • Inj ceftriaxone 2 x 1 gr • inj dexketoprofene 3 x 1 • acc krs • Po etorvel 2 x 60mg	Agung, Wafi, Kikis, Danang
------------	-------	--	-------------------------------

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Karena pembiusan dilakukan oleh perawat (Agung), padahal itu bukan kewenangan perawat.
2. Pasien tidak mengalami cedera langsung dalam laporan ini (tindakan berhasil, pasien stabil), tetapi risiko cedera sangat tinggi bila terjadi komplikasi anestesi.

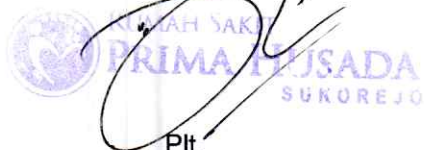
IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Dari sisi pasien → tidak ada kerugian nyata pada saat itu , tapi ada potensi kerugian serius bila kejadian berkembang

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit Iko	Seharusnya mandat yang di berikan tidka sepenuhnya di serahkan kepada perawat anastesi karna bertentangan dengan RKK perawat anastesi . kedepanya harus ada pendampingan dari dokter anastesi jika ada operasi .	
*Kepala Keuangan RS		
*Kabid Pelayanan Medik	- Lakukan pelaporan pada mod jika ada kendala - Dilarang melakukan tindakan diluar RKK	
*Kabid Keperawatan	—	
*Kabid Penunjang Medik	• Ketidaksiharian dgn kewenangan klinis perawat Anastesi • Pendelegasian tugas tidak boleh diberikan jika dr Anastesi tidak ada / tidak hadir	
*SDM RS	- Tidak boleh melakukan tugas diluar kewenangan - lapor mod apabila ada kendala	

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



Heni Indra W, S. Kep. Ns. M. Kep

Pembuat Kronologi



(Agung Pratama, Amd. Kep)

Catatan Direktur : Saat dokter anastesi yang berjaga tidak bisa berjaga maka dialihkan ke dokter anastesi lain yang bersip